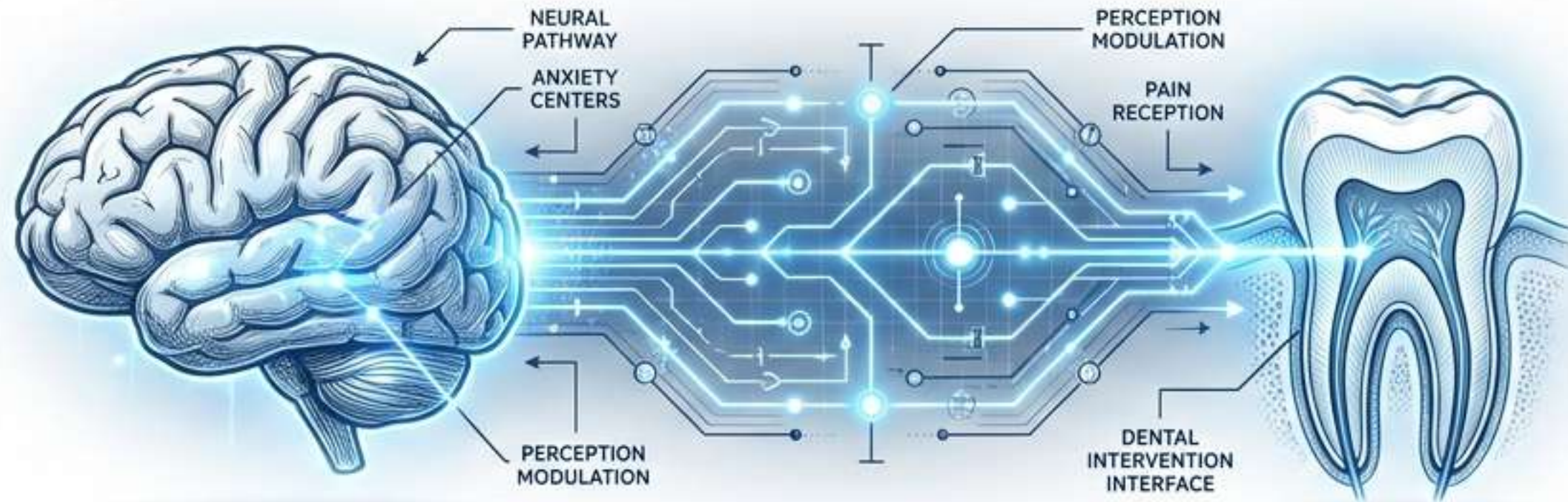


Approche Psychologique du Patient au Cabinet Dentaire

Le Guide Clinique Exhaustif (Diagnostic, Environnement, Pédodontie et Sédation)

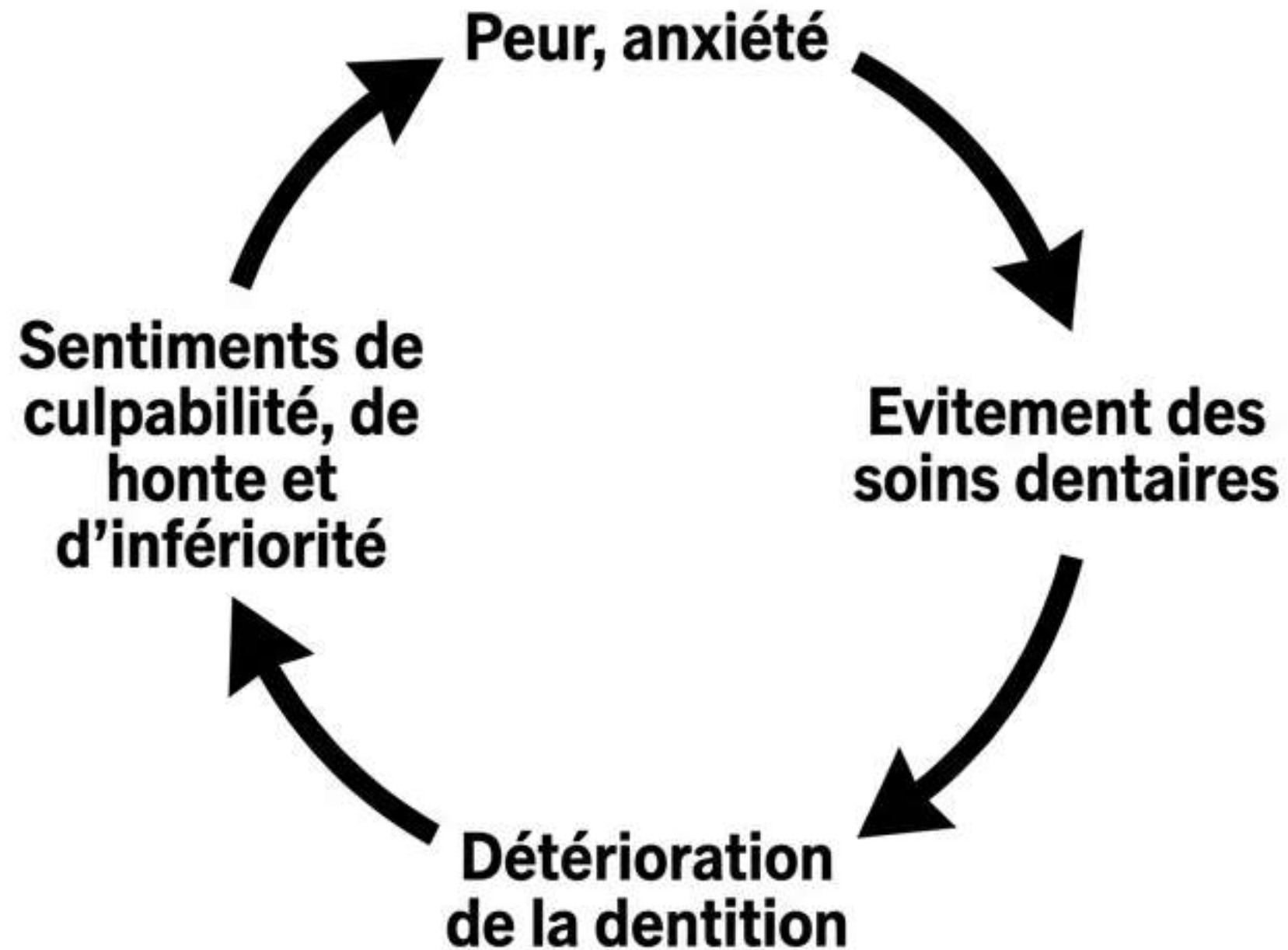


Axiome Clinique Absolu : Avant la prise en charge du patient pour une pathologie donnée, il faut d'abord lui assurer une prise en charge psychologique.



Contexte : Le cabinet dentaire est un milieu hautement stressant. Le praticien est souvent assimilé à des actes de mutilation toujours douloureux.

L'Odontophobie : Problème de Santé Publique & Modèle de Berggren



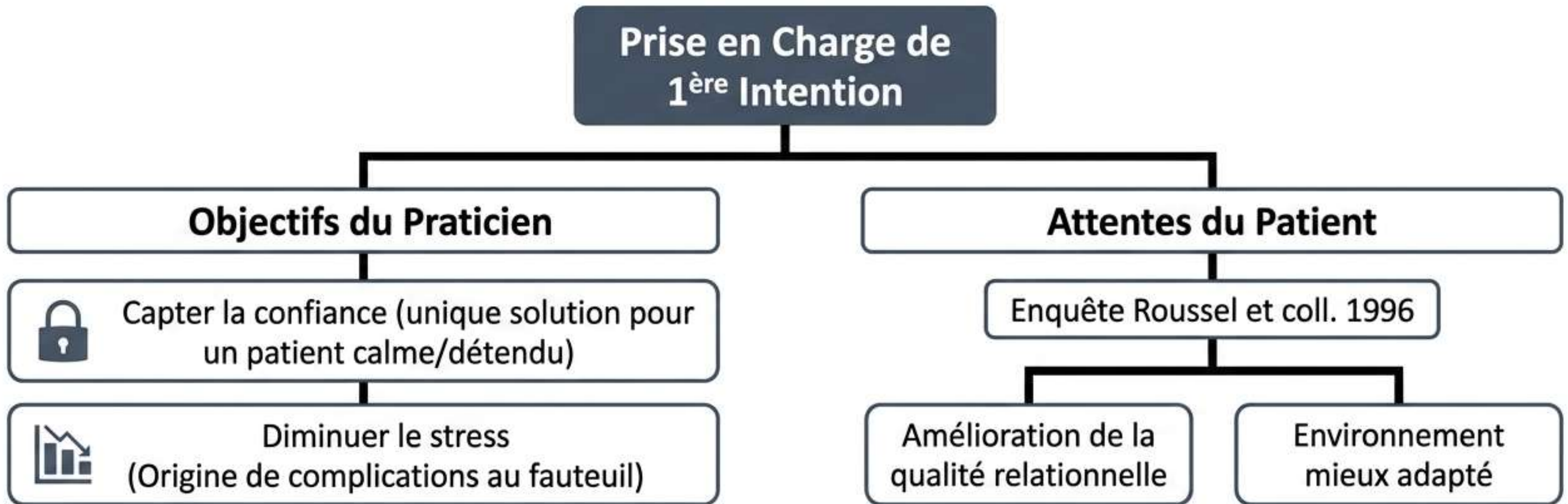
Origine Temporelle : L'anxiété des adultes face aux soins dentaires débiterait pour la moitié des cas (50%) dans l'enfance.
[Predicted – Chiffre clé fondamental hautement testable]

Conséquences Cliniques (Effet Cascade) :

1. Perturbe le bon déroulement des soins.
2. Conduit à un évitement des soins et des contrôles.
3. Entraîne une dégradation progressive de l'état bucco-dentaire.

Conclusion : À l'origine d'un véritable problème de santé publique. Gestion adéquate essentielle pour des résultats de traitement optimaux.

Prise en Charge de Première Intention (Objectifs & Attentes)



Facteurs Aggravants : L'anxiété est d'autant plus grande que le malade présente une pathologie lourde : cardiopathie, hémopathie, diabète. [Predicted – Liste stricte d'états systémiques favorisant les complications]

L'Environnement du Cabinet : Facteurs Visuels et Thermiques



Couleurs

Ont un impact émotionnel, psychologique et suggestif.

Règle : Doivent dégager une ambiance apaisante. Toujours claires et relaxantes.



Éclairage

Optimal requis pour le confort et la performance visuelle.

Risque : Une pièce mal éclairée provoque un sentiment d'insécurité.



Température

Pas de température idéale unique, mais une plage de **confort thermique** (état de satisfaction) pour un maximum de patients.

Règle Thermique : Une température constante, comprise entre 20° et 24° est souhaitée. [Predicted – Valeur numérique exacte à fort potentiel QCM]

L'Environnement du Cabinet : L'Auditif, l'Olfactif et l'Instrumental

Bruits



Sources

Turbine, aspiration, soupirs, exclamations. Les soins ne doivent jamais être perçus par les autres patients.

Solutions

Insonorisation maximale. Musique (vertus relaxantes, anxiolytiques, dérivation de l'attention).

Odeurs



Souvenirs dentaires pénibles.

Éviter particulièrement l'odeur de l'eugénol. [Predicted – Exemple précis d'odeur anxiogène]

Nettoyage immédiat des flacons et plaques de verre, aérer souvent, désodorisants légers.

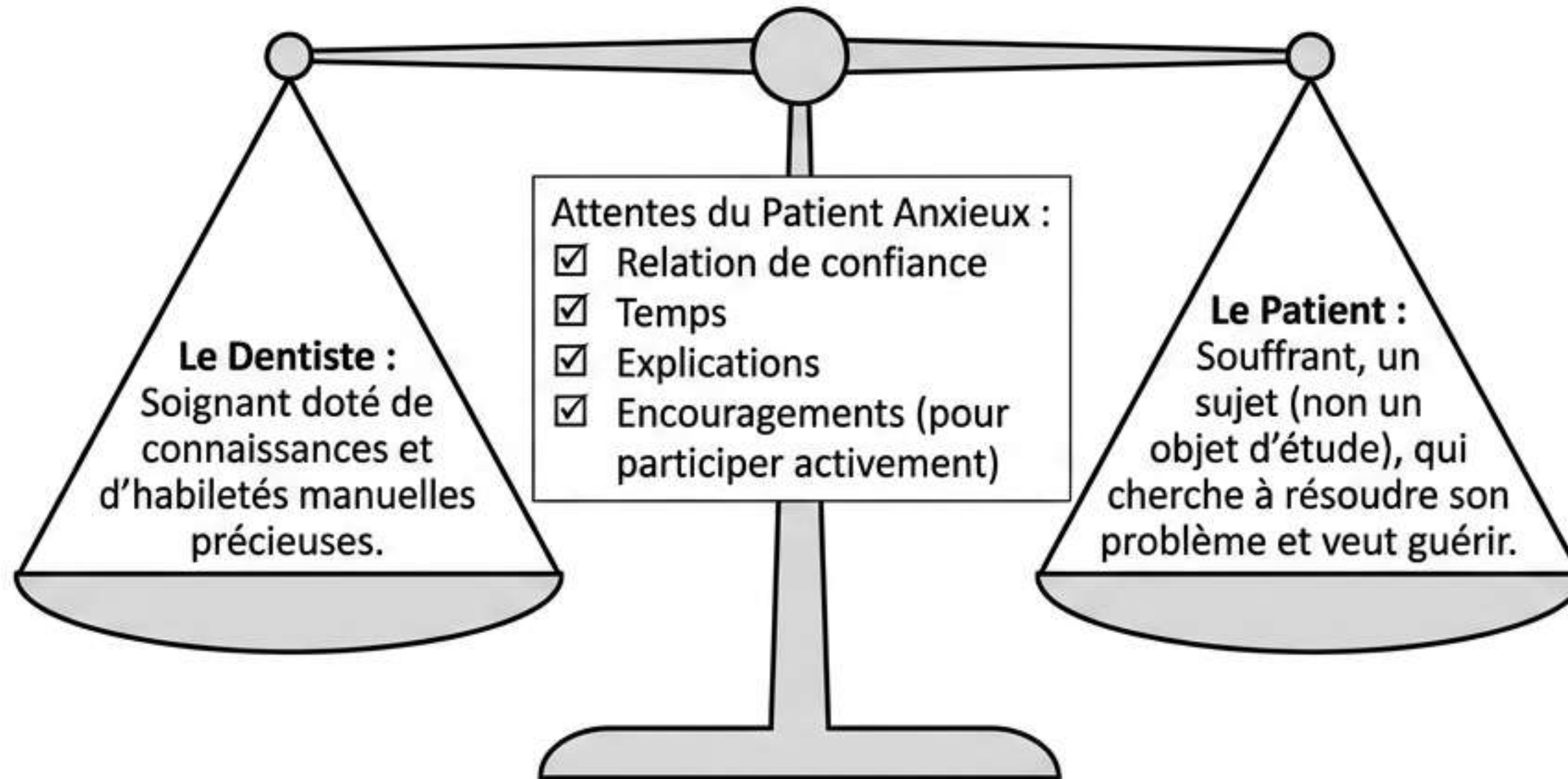
Instruments



Caractéristiques inspirant la crainte : Métal, pointus, piquants, tranchants.

Ne pas étaler tout le plateau sur le plan de travail avant l'entrée du patient.

Les Acteurs et l'Accueil : La Relation d'Aide Professionnelle



L'Accueil

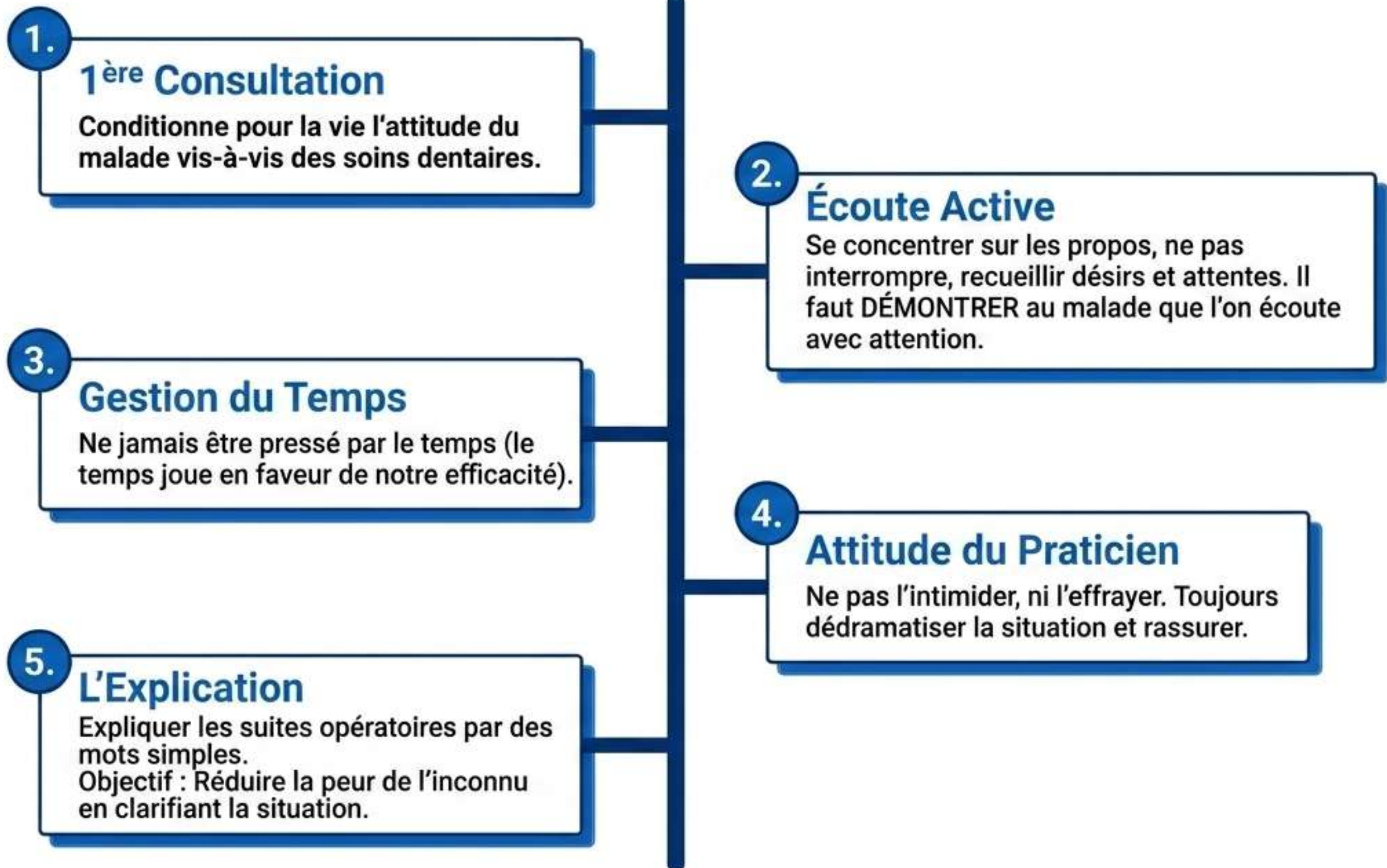
Commence par des assistantes formées ou expérimentées. Doit être calme, chaleureux, affectueux et sécurisant.

La Salle d'Attente

Les délais excessifs augmentent l'anxiété.

Seuil Temporel : Si l'attente dépasse les 15 minutes, elle doit être mentionnée et expliquée au patient.
[Predicted – Borne temporelle stricte]

Le Chronogramme de la Consultation (Attitude et Écoute)



Particularités de l'Enfant : Origines et Relation Triangulaire



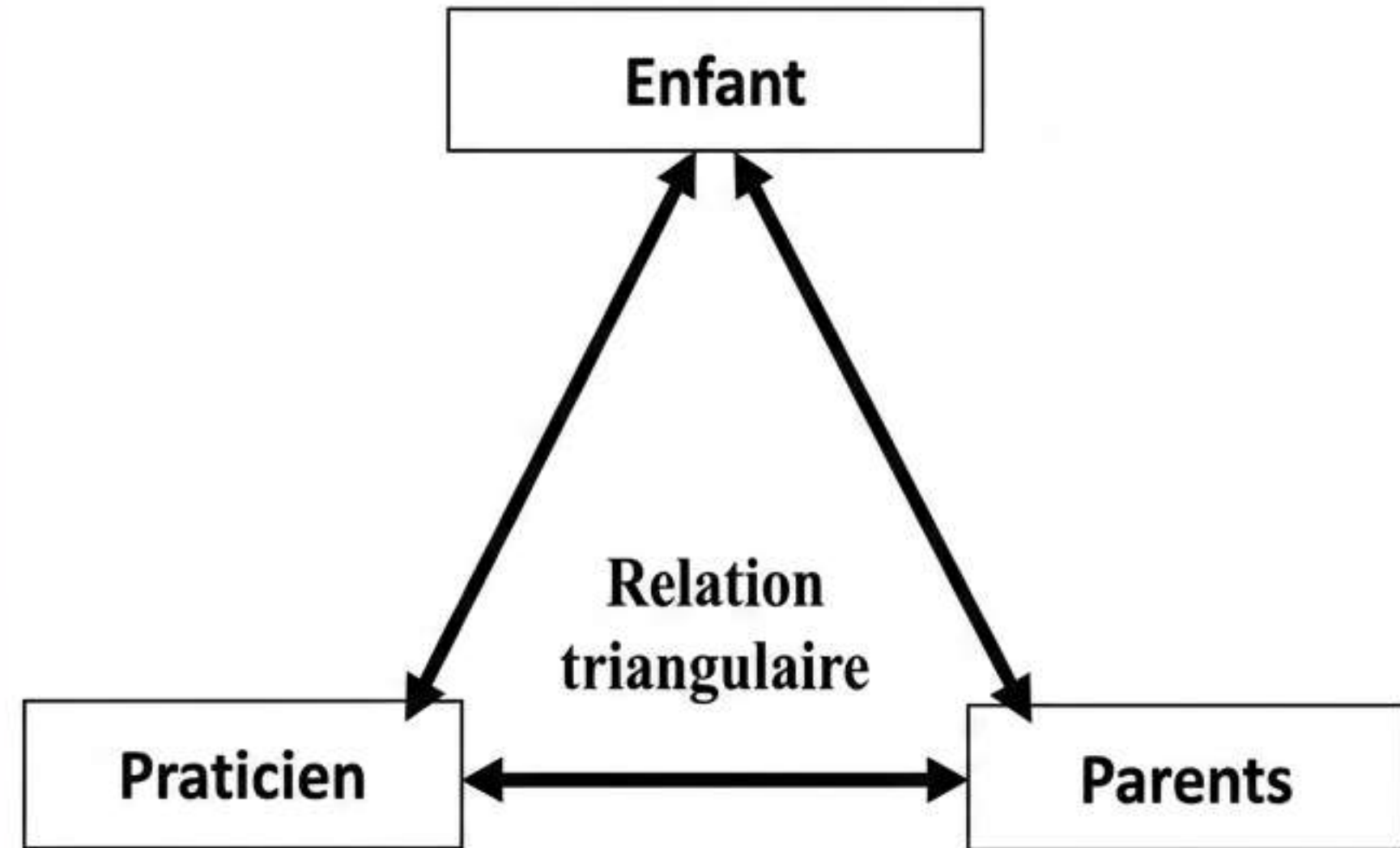
Incidence Temporelle : L'odontophobie se développe essentiellement dans l'enfance, plus rarement à l'adolescence, et quelques fois à l'âge adulte.



Origine de l'Angoisse : Ne provient pas, la plupart du temps, d'une situation vécue, mais d'un mythe transmis par l'inconscient collectif.



Différence Fondamentale : L'enfant n'est pas un adulte en miniature. Il utilise un mode de communication avec de nombreux échanges tactiles et un langage corporel très important. Les réactions paraissent fréquemment démesurées. Nécessite des aptitudes pour amener la coopération directe.



La triade enfant/praticien/parents

La Triade : Gestion de l'Enfant et Rôle des Parents

Rôle de l'Enfant

- **Analyse Visuelle** : Observer le comportement (attente, entrée, installation, gestuelle, paroles).
- **Type de Relation** : Une relation DIRECTE (Praticien-Enfant) est à privilégier.

Le Relais Parental (Exceptions) : Le parent prend le relais de l'information dans 3 cas : Troubles psychiques, Pathologies chroniques/aigües, et s'il est très jeune (0 à 2 ans). [Predicted – Tranche d'âge justifiant le relais]

Le Rôle des Parents

À FAIRE	À NE PAS FAIRE
✓ Prévenir quelques jours avant (sans menace ni sympathie excessive). ✓ Présenter comme un jeu/moment plaisant (renforcement positif). ✓ Favoriser des visites de routine sans symptôme.	✗ Ne pas exprimer ses propres craintes. ✗ Ne pas présenter la consultation comme une punition. ✗ Ne JAMAIS faire de promesse sur ce que va faire le dentiste.

Exclusion de la salle de soin : Trois profils de parents sont exclus le temps du soin : Parents hyper anxieux, Parents hyper protecteurs, et Parents dominateurs qui humilient l'enfant. [Predicted – Critères stricts d'exclusion]

Le Praticien & Méthodes de Communication chez l'Enfant (1/2)

La Première Consultation : Prendre le temps de faire connaissance, établir un contact positif, motivation à l'hygiène et prophylaxie (brossage au fauteuil).

RÈGLE D'OR : Hors urgence, aucun traitement invasif n'est entrepris lors de la 1^{ère} consultation (parents informés à l'avance). [Predicted – Règle clinique absolue]

Méthode 1 : Pré-exposition

Familiariser pour éliminer le facteur inconnu.



Grosse lumière =
un soleil qui
éclaire la bouche.



Petit miroir =
regarder les
dents.



Jet d'air = faire
actionner et
sentir l'effet pour
dédramatiser.

Méthode 2 : Show-Tell-Do (Expliquer-Démontrer-Faire)

Montrer l'instrument, décrire, décrire la façon de procéder.

Toujours dire ce que l'on va faire et faire ce que l'on a dit.



Danger : Ne jamais mentir ou faire des fausses promesses (mise en péril de la confiance et de la relation de soin).

Méthodes de Communication chez l'Enfant (2/2)



Contrat de Confiance (Stop signal)

À partir de 5 ans.
[Predicted – Borne d'âge précise]

Convenir d'un signe (lever la main) pour arrêter le soin.
Praticien assure un arrêt immédiat.
En contrepartie, l'enfant ne doit pas simuler ou mentir.



Distraction



Faire participer l'enfant ou dériver son attention.

- **Participation** : Confier un miroir pour qu'il suive le traitement.
- **Dérivation verbale** : Raconter une histoire, chanter, parler des vacances ou personnages préférés.
- Le parent peut aider en prenant part à la discussion.

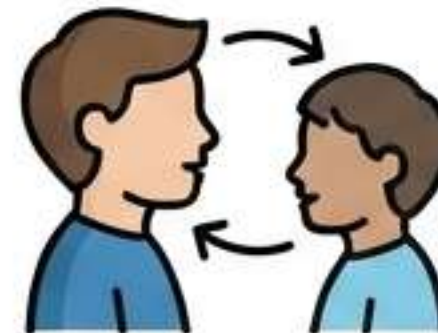


Renforcement Positif

Féliciter un comportement coopérant ou une amélioration.

Valoriser le bon résultat (même mineur) pour encourager la répétition.

Règle : Ignorer/écarter les difficultés comportementales pour laisser place à la valorisation du soin finalement réussi.



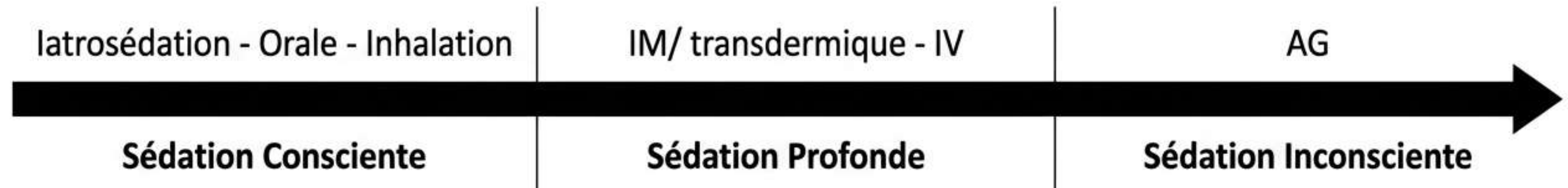
Modélisation

Apprentissage du comportement au fauteuil par l'observation.

- Observer un enfant plus grand : but = suivre l'exemple.
- Observer un enfant plus petit : but = faire appel à l'amour propre de l'enfant en apprentissage.

Le Recours Médicamenteux et le Gradient Thérapeutique

L'Échec Psychologique : Parfois, malgré la préparation, le patient reste tendu, craintif et agité. Les substances pharmacologiques sont un traitement ponctuel des symptômes (ne résolvent en aucun cas le problème sur le long terme).	Limites et Inconvénients : Effets secondaires, coût, difficultés de mise en œuvre en cabinet libéral, contre-indications majeures.	Alternatives Non Médicamenteuses : Hypnose (couplée à la relaxation) et Acupuncture (dans certains pays).
---	---	--



Règle du Gradient (ASA / Malamed 2009) : Le praticien se doit de toujours choisir le niveau de sédation le plus bas efficace. [Predicted – Principe de sécurité]

Modalités de Sédation : Prémédication et MEOPA

Sédation Orale (Prémédication Sédative)

Pour la prise en charge des manifestations mineures d'anxiété (la plus répandue).

Molécules : Benzodiazépines et Antihistaminiques (principalement l'hydroxyzine).
[Predicted – Pharmacopée spécifique]

⚠ **INTELLIGENCE EXAMEN (EMD 2020 Q3) :**

La prémédication sédative :

- Permet le bon déroulement de l'intervention.
- NE remplace **PAS** l'approche psychologique.
- Doit tenir compte des prescriptions médicamenteuses en cours.
- N'est **PAS** systématique en présence d'un état infectieux local. [Ref: Q3 EMD 2020]

Sédation par Inhalation (MEOPA)

Mélange Équimolaire Oxygène – Protoxyde d'Azote.

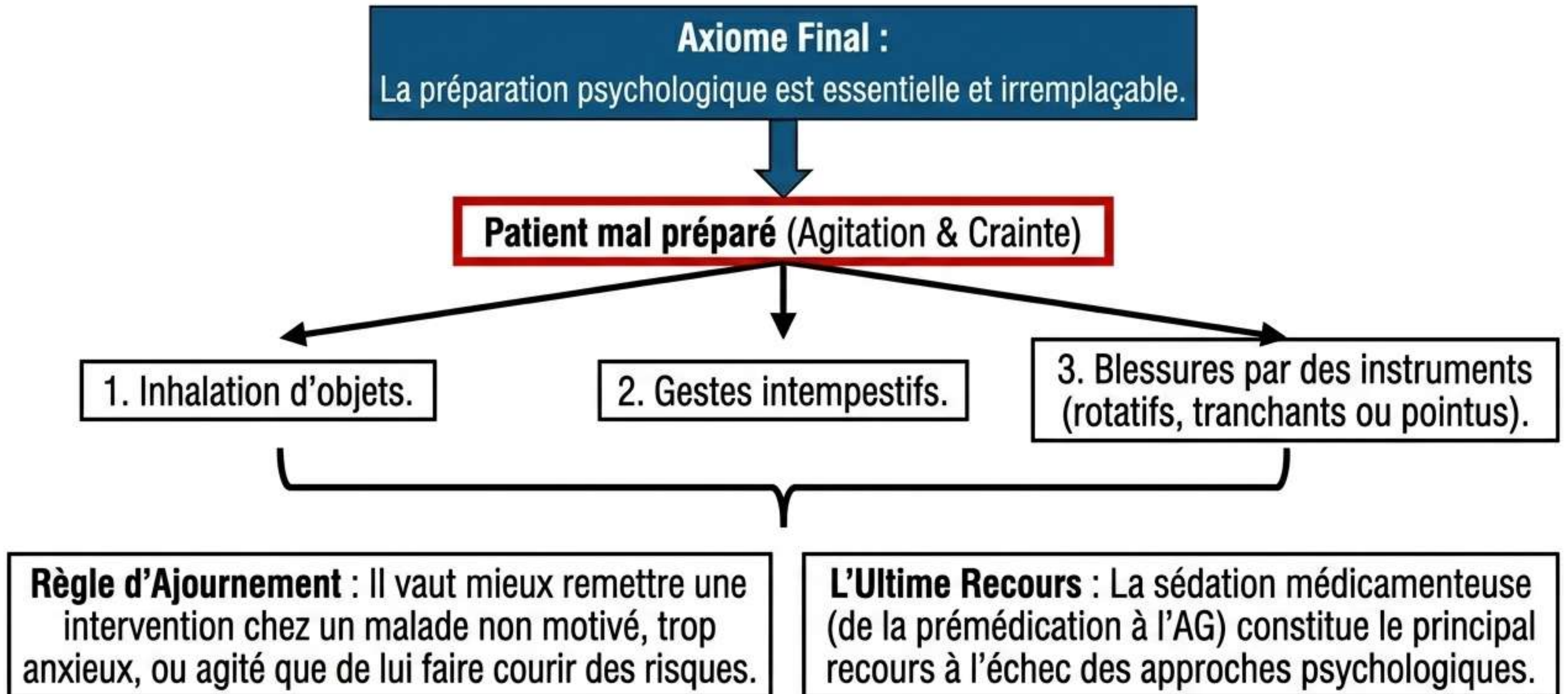
Effet anxiolytique, euphorisant, amnésiant, analgésique. (Anxiété sévère/modérée).

Sécurité Absolue : N'entraîne AUCUNE dépression respiratoire. Aucun effet sur FC/PA.
[Predicted – Piège classique]

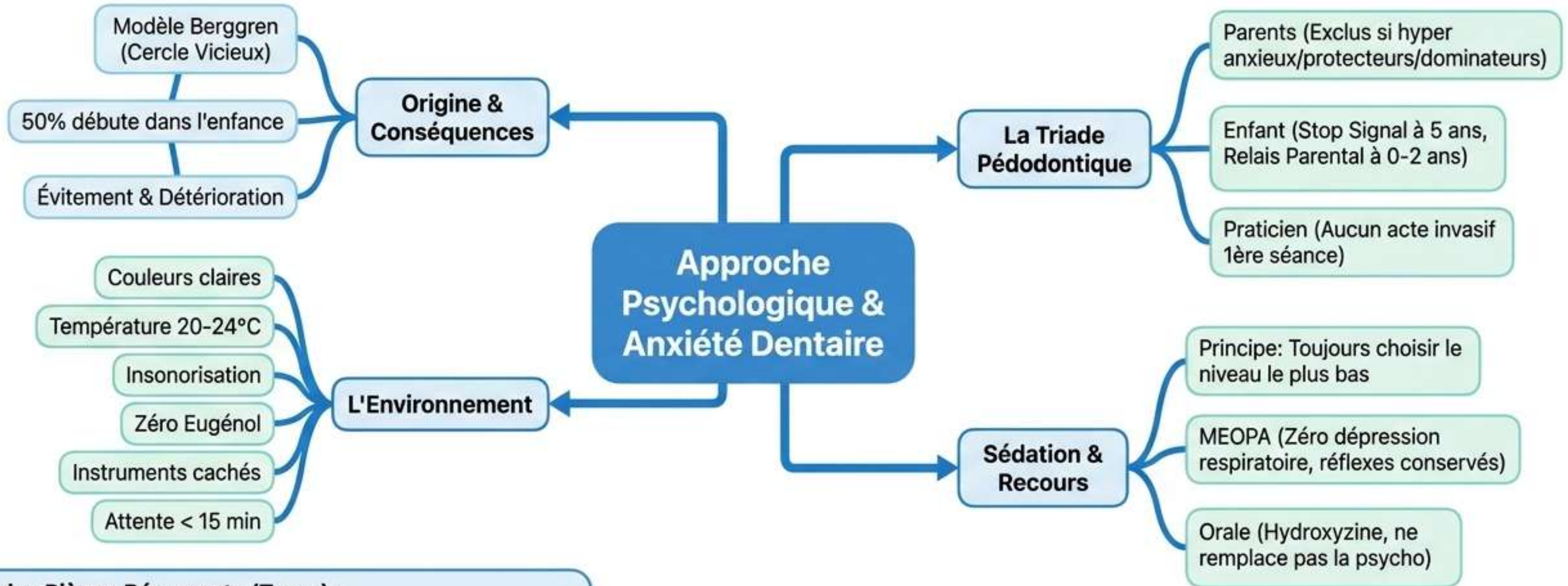
Réflexes laryngés **CONSERVÉS**. Patient conscient (répond aux commandes). [Predicted]

Effets indésirables (mineurs/réversibles rapidement) : Nausées, vomissements, vertiges, céphalées.

Conclusion : Risques Cliniques et Règle d'Ajournement



Cartographie Mentale & Stratégie d'Examen



Analyse des Pièges Récurrents (Traps) :

- **Rôles stricts** : Confondre l'aide médicamenteuse avec un remplacement de la psychologie (Faux, cf. EMD 2020).
- **Sécurité MEOPA** : Penser qu'il endort ou abolit les réflexes (Faux, sédation consciente).
- **Chiffres fixes** : Inverser les âges (5 ans pour le stop, 0-2 ans pour le relais), oublier la température (20-24°C).